ONEMA-POP-052 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Manutenção Segura de Port-a-Cath e Reconhecimento de Possível

Síndrome de Pinch-Off

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de manutenção segura de port-a-cath e reconhecimento de possível síndrome de pinch-off, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade.

Não substitui prescrição, avaliação médica nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

EPIs, material de antissepsia e acesso estéril compatível, prescrição e IFU do reservatório/agulha. Equipamentos profissionais/EPIs: enfermeiro ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita presencial, equipamentos de avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Checar modelo de Port, local de implante, dor na região clavicular, dificuldade de infusão e histórico de radiografia.

Confirmar identificação, consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Identificar dispositivo, prescrição e habilitação para punção/manutenção; verificar IFU.

02. Inspecionar pele, loja, trajeto e região clavicular antes de manipular.

03. Suspeita de pinch-off diante de dor, resistência posicional ou disfunção recorrente: suspender uso.

04. Não tentar vencer resistência, não realizar flush sob pressão nem manipulações posturais para manter infusão.

05. Comunicar equipe vascular para avaliação e imagem apropriada; não liberar por retorno transitório de fluxo.

06. Se houver suspeita de fratura, embolização ou sintomas torácicos, acionar urgência.

07. Somente após exclusão de complicações, executar manutenção prescrita com técnica asséptica e IFU.

08. Registrar sinais, tentativa não realizada/realizada, dispositivo, comunicação e plano.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Suspeita de fratura, embolização, dor torácica, dispneia: interromper e encaminhar imediatamente. Na emergência, acionar

SAMU 192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Explicar sinais de disfunção e proibição de forçar lavagem ou infusão.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

CDC catheter guidelines; INS Infusion Therapy Standards (2024); IFU do dispositivo | Conferir aplicação integral ao cenário

brasileiro e IFU específico antes de liberação assistencial.

aplicativo.